EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	87304
SERVICIO	:	MEL HOMBRES HSC			
FECHA	:	25-06-2024			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: PATRICIA ANGELICA HERNANDEZ CASTRO			RUN	: 4.508.824-3
F.Nac	: 20-11-1945	Edad	: 78 AÑOS, 7 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: BILBAO 667			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 997078350		
Fecha Ingreso	: 2024-06-13	Fecha Egreso	: 25-06-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. L03.1-CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIENBROS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1-Celulitis de EEII izquierda
--> Hematoma en EEII sobreinfectado resuelto
2-Discoagulopatia por TACO resuelta
3-FA RVA
4-ICC FEVI 40%
5-ERC Etapa G3aA1
6-EPOC GOLD B
7-DM2
8-Obesidad
9-DLP
10- Dependencia severa ABVD

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. T14.0-TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE REGION NO ESPECIFICADA DEL CUERPO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina postrada de 79 años con antecedentes de postracion, ICC FEVImr, FA RVA en terapia TACO, linfedema cronico, ingresa el dia 13/06 por cuadro clinico de 1 semana de evolucion previo a consulta, caracterizado por acentuación del aumento de volumen de extremidad inferior izquierda asociado a dolor. paciente ingresa en regulares condiciones generales, con extremidad dolorosa, laboratorios iniciales destaca leucocitosis con desviación izquierda, estudios en contexto de TVP, pesquizan dimero d elevado en 2.209 con ecografia de extremidades que reporta examen negativo para TVP, y evidencia un hematoma subcutaneo en la region posterior de pierna izquierda, se solicitan pruebas de coagulacion, donde destaca INR en 7.13, se revisa control previamente labil en TACO, se ingresa a sala medicina en contexto de una posible celulitis por clinica + discoagulopatia secundaria a mal ajuste de TACO, paciente evoluciona clinicamente estable, con medidas profilacticas kinesicas y uso de MAE sin anticoagulacion, se resuelve discoagulopatia, logrando inr actual estable. se realiza ajuste de tratamiento de patologias cronicas, logrando estabilidad hemodinamica y sin descompensacion. Desde el punto de vista infeccioso, paciente recibio cefazolina por 5 dias, rotado a clindamicina por 7 dias, de buena respuesta, con parámetros inflamatorios en franco quiebre a la baja, buena respuesta clínica, con dolor leve en extremidades y edema compatible con linfedema cronico. ECO doppler control evidencia resolucion de hematoma, con contenido vascular organizado, Dado evolucion clinica, paraclinica y ecografica favorable, con buena tolerancia a rehabilitacion kinesica, se decide alta a HODOM para rehabilitacion.

PLAN DE MANEJO:

-Paciente con FA RVA, con uso de TACO, cuadro clinico de ingreso es secundario a discoagulopatia, destaca un INR labil, con mal control, se decide suspender TACO, estabilizando INR, actualmente de buen control INR sin TACO, paciente con comorbilidades multiples, sin deterioro cognitivo, se destaca sin deterioro severo de la funcion renal, G3aA1, se discute con equipo de medicina interna, paciente se beneficiaria inicio de terapia con DOAC en 14 dias, sugiriendo dabigatran 110mg c/12 horas vo a iniciar en proximo control medico, en 14 dias.

INDICACIONES AL ALTA

1. Continuar rehabilitación kinésica en HODOM por 5 dias
2. Reposo relativo asistido con medias compresivas
3. Regimen liviano bajo en sal, bajo en azucar
4. Hidratacion oral, maximo 1500 cc/dia
5. Losartan 50mg c/dia vo
6. Bisoprolol 2,5mg c/dia vo
7. Furosemida 40mg 1/2 c/dia vo
8. Espironolactona 25mg 1 c/12 horas vo
9. Empaglifozina 10mg c/dia vo
10. Atorvastatina 20mg c/dia vo
11. alopurinol 300mg 1/2 c/dia vo
12. Paracetamol 2comp c/8 horas vo SOS dolor
13. Acido folico 1 comp vo c/dia

14. Ferranim 1 comp vo c/dia
15. Omeprazol 20mg c/dia vo
16. Quetiapina 25mg c/noche vo
17. Lactulosa 20cc c/dia vo
18. Bromuro de ipatropio 2 puff c/6 horas por AEC
19. Brexotide 2 puff c/12 horas vo
20. Metformina 850mg c/dia vo
21. Control en CAE medicina interna en 14-20 dias para definir inicio de DOAC
22. Continuar en programa de APS
23. Eventualidades reconsultar a SU

EXÁMENES Y RESULTADOS

Laboratorios de Alta: Albumina : 2,6 Creatinina : 1,10 Calcio : 8,4 mg/dL Fosforo : 3,2 mg/dl LDH : 370 MDRD 48,04 Lactato : 0,9 mmol/L Proteina C Reactiva : 20,3 Uremia : 60 Sodio (Na) : 135,00 mmol/L Potasio (K) : 4,90 mmol/L Cloro (Cl) : 106,00 Hemoglobina : 8,8 Hematocrito : 26,5 leucocitos : 9,30 mil/ul Plaquetas : 343
Eco doppler 25/06/24 de EEII resolucion de hematoma, con contenido vascular organizado

Control en: 30 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO